

04 - 4 jejuno ileon sono maker

Donc, je vais vous conseiller de repartir d'un point de vue visible, spécialement à un point de vue de l'Instagram et de l'art. On va commencer par le premier point, qui est le jugement qu'il y a. Donc, certains objectifs doivent être fixés à la fin du cours. Donc, il faut connaître la situation, la configuration externe du jugement.

Rapport au jugement, sa vascularisation, ses rapports et son moyen de fixité, qui est le mesentère. Pour ce faire, on va se retrouver vers le point suivant. Comme définition, le jugement il y a, c'est la deuxième partie de l'intestin grêle.

En principe, l'intestin grêle est composé du jugement, du jugement et du jugement. On a l'habitude d'appeler l'intestin grêle uniquement du jugement et du jugement. L'intestin grêle est composé du jugement, du jugement et du jugement.

Le chapitre va concerner le jugement et l'union. Le jugement et l'union, c'est la deuxième partie de l'intestin grêle, qui va s'étendre de l'angle du grêle du génôme, appelé angle du grêle. Ça, c'est la limite entre le jugement et le jugement, c'est l'angle du grêle du génôme.

Donc, jusqu'à la valvule qui ne s'étale. C'est l'accouchement de la dernière hanche qu'il y a avec le courant ascendant. La fonction principale de cet intestin, de ce jugement et de l'union, c'est la digestion des aliments et l'absorption qui se fait au maximum au niveau du jugement.

Comme on l'a dit, le jugement et l'union sont composés de deux segments. Le jugement représente les deux cinquièmes supérieurs de l'intestin et l'union représente les trois cinquièmes intérieurs de l'intestin. Donc, cet intestin grêle ou ce jugement et l'union, il occupe l'épase sous-mésoporique.

On parle d'épase sous-mésoporique par rapport au mesoporon transverse. Ça, c'est le mesoporon transverse et il est attaché au mesoporon transverse. On parle d'un épase sous-mésoporique, c'est-à-dire sous le mesoporon transverse et d'un épase sous-mésoporique, c'est-à-dire au-dessus du mesoporon transverse.

Le jugement et l'union occupent l'épase sous-mésoporique de la cavité abdominale. Vous avez remarqué lors de ce cours que parfois les slides sont un peu chargés, mais ils sont illustrés par les schémas. J'ai fait exprès d'apporter le maximum de renseignements pour que ce cours soit complet et on n'avait pas cherché à brander à gauche pour trouver une information.

Dans ce jugement et l'union, il est en forme de plusieurs hanches flottantes qui sont au nombre de 15 à 16 et sont disposées en 5 groupes. Deux groupes qui sont verticaux. Ici, il s'agit d'une union.

Deux groupes droit et gauche. Deux groupes verticaux latéraux, droit et gauche. Deux groupes horizontaux, supérieurs et intérieurs.

Et un groupe bicentrale. C'est schématique. On voit ici le jugement.

Il y a des anses qui sont disposées. Ici, il n'y a pas de disposition de manifestation. C'est franchement vertical, horizontal.

Mais généralement, le jugement est vertical. L'union est horizontale. Et l'union est verticale.

Il y a une partie centrale, ici, au milieu. Ce jugement est composé de 5 groupes. Deux groupes verticaux latéraux, droit et gauche.

Deux groupes horizontaux, supérieurs et intérieurs. Et un groupe centrale. Chaque anse a la tête.

Si on fait une coupe de l'intestin, elle se présente comme un tube qui creuse et s'élimine. Elle est en forme de U. Dans l'épicère, vous la trouverez en forme de V. Mais elle est en forme de U. Cette anse présente une grande cavité qui s'éblouit vers le milieu. Et les deux branches de cette anse-là vont être en contact avec les branches des anses collatérales.

Si on fait une coupe de l'intestin, elle va se présenter comme un tube qui creuse et s'élimine. Chaque anse est en forme de tube dont la grande cavité se dirige vers l'immédiat. Les branches de cette anse vont être en contact avec les branches des autres anses, qui sont la tête latérale.

Cette digénération mesure environ 5 à 6 mètres. Pour les anses grèves, elles mesurent en moyenne 20 à 40 cm. Le diamètre de ce digénome ion va en diminuant.

C'est-à-dire que le digénome a un diamètre qui est important par rapport à l'ion, ceci expliqué par sa fonction. Au niveau du digénome, on a un maximum d'absorption des nutriments, ce qui explique son diamètre. On va voir sur la structure histologique du digénome.

Le digénome est caractérisé par la présence de multiples vélocités qui permettent cette absorption des nutriments. Le diamètre est diminué progressivement. Le digénome a un diamètre de 4 cm, l'ion de 2,5 cm.

Si on vous demande le diamètre moyen, c'est généralement entre 2 et 3 cm. Le diamètre moyen de l'intestin grève, c'est entre 2 et 3 cm. Le digénome a un diamètre de 4 cm.

Par contre, l'ion a un diamètre de 2,5 cm. Ce digénome est très bien vascularisé. Il est plus épais et plus rouge à cause de sa vascularisation.

Chaque onse présente deux faces. Elles sont convexes et deux bords. Il y a un bord libre.

Sur cette chaîne-là, le bord libre. Dans la capitale communale, il est antérieur et complexe. Il y a un bord dit adhérent au mésentérique.

Il est appelé au mésentère. C'est le bord adhérent au mésentère, qui est postérieur et concreux. Sur ce schéma-là, on va voir la structure histologique du digérome de l'ion.

L'apparent intestinal est formé de 4 couches qui sont de la superficie vers la lumière. On a la serreuse, appelée également le périodre viscéral. Il y a les musculuses composées de deux couches.

La première est longitudinale externe. La deuxième est circulaire interne. Il y a également, dans la troisième couche, la semiteuse, richement vascularisée.

Et la muqueuse, qui contient les glands d'oeufs. Surtout les glucins et les brûlins. Comme on l'avait déjà dit, la surface interne de l'intestin, ou du génome de l'ion, présente des rugosités.

Vous voyez cet aspect-là, en rose. Ce sont les rugosités, qui sont richement vascularisées et qui vont participer à l'absorption du nutriment. Il y a également les molécules groupées en amal, qu'on appelle les particulaires.

Et il y a les plis semi-circulaires. Ce sont des plis semi-circulaires, pour invoquer l'intestinal. Les rugosités sont plus importantes et plus nombreuses au niveau du gigelon qu'au niveau de l'ion.

Donc, comme moyen de fixité, il y a un seul moyen de fixité de l'intestin grais, qui est le mesenterre. C'est-à-dire cette porte-là de graisse. C'est cette graisse-là, qui relie l'intestin grais à la paroi abdominale postérieure.

Donc le gigelon, le gigelion, il est mobile. C'est pas comme le côlon. Vous avez étudié le côlon ? Oui.

Donc vous avez vu que le côlon, il présente des segments qui sont fixes et des segments qui sont mobiles. Par contre, le gigelion est entièrement mobile, sauf au niveau de ses extrémités. Donc, la première extrémité, c'est en revient sur le schéma.

Donc, au niveau de la longueur du gigelon, c'est-à-dire longueur de dresse, et au niveau de la barbule plus sécale, l'appouchement de la dernière ancilliale, donc au niveau de la barbule de poids. Donc, c'est l'intestin grais, il est fixe au niveau des extrémités, c'est-à-dire au niveau de la barbule abdominale, qui est longue de dresse, et au niveau de la barbule plus sécale, la barbule de poids, et par son bord adhérent à la paroi abdominale postérieure. Ça, c'est le mesenterre.

C'est une image préopératoire, c'est un patient qu'on a opéré. Vous remarquez ici le colon transverse. Ça, c'est le colon transverse avec sa bande-tête, qui est basculée dans le sac, et on regarde la main.

Donc, il y a le grand épiglon, ou le grand homophobe. Ça, c'est le mysocolon transverse. Donc, on a dit que l'intestin grais, où le gigelon se situe, occupe le phase sous-mésopoli, c'est-à-dire sous le mesopolon transverse.

Ce mesenterre-là, il représente deux faces, une face antérieure, on voit ici sa face antérieure, et la face postérieure, elle se trouve en arrière. Ce mesenterre a deux faces, une face antérieure, et l'autre face est en arrière, une face postérieure. Il a deux extrémités, une extrémité supérieure, en regard de longueur d'hydrologie humaine, donc c'est un point qui est fixe, et l'extrémité inférieure, elle répond à la jonction héliocétale.

Donc, un mouvement, deux faces, antérieure et postérieure, des extrémités, une supérieure, en regard de longueur d'hydrologie humaine, comme on le prête, et la deuxième, en regard de la jonction héliocétale. Il y a un bord libre, donc intestinal, ça c'est où ? Ça c'est le bord libre du mesenterre, le bord libre intestinal est apporé à l'intestin grec. Donc c'est un bord libre.

Il y a un bord parépal, on parle d'un bord parépal, c'est un bord qui est fixe, c'est la racine du mesenterre. Donc, cette racine du mesenterre, elle adhère à la paroi ici, sur ce schéma là, donc on a sectionné le mesenterre et l'intestin grec, et ce recul là, représente la racine du mesenterre, donc elle adhère à la paroi postérieure. Cette racine du mesenterre, une mesure en grand, 15 centimètres, elle présente trois portions.

Donc une première portion qui oblique, et qui correspond au duodenum ascendant, on va étudier le duodenum contraire. Le duodenum est composé de 4 parties, la première portion duodenum qui est horizontale, la deuxième verticale, la troisième qui est horizontale, et la quatrième qui est oblique. Donc, le duodenum ascendant c'est le quatrième duodenum, donc, qui va qui va sous 8 parts, ça c'est la première portion du duodenum.

Donc, cette racine du mesenterre, représente trois portions, une portion qui oblique, et qui répond au duodenum ascendant qui est le quatrième portion du duodenum, une portion verticale, et une portion oblique en barrière droite, qui rejoint la postérieure droite, ça c'est la postérieure droite, où il y a le second, la dernière rancélière, c'est quand il atterrisse. Donc, pour les rapports de ce duodenum, on a dit déjà que le duodenum occupe la partie latérale de la quatrième, et il est plus étendu à gauche qu'à droite. Le côté gauche, il est plus étendu, autant plus dense que le côté droite.

Je pense que j'ai fait vite je vais me ralentir sur la troisième, deuxième, donc j'ai fait c'est parti. J'ai essayé d'illustrer le texte par des schémas, et je n'ai pas le temps pour vous expliquer, pour vous montrer les schémas. D'accord ? Merci.

Donc, ces rapports antérieurs, c'est-à-dire les rapports qui se situent en avant, c'est le grand débutant, qui prouve tout l'indestin réel, et la paroi abdominale antérieure. Ce sont les deux rapports antérieurs du duodenum. En arrière, il y a la paroi abdominale antérieure qui n'est pas présentée sur le schéma, mais on devine ici ce qu'il y a en antérieure, c'est les gros vaisseaux, le racisme, et la paroi abdominale antérieure.

Il y a également les organes rétro-péritoriaux, c'est-à-dire qui se trouvent derrière le péritoine par

les pattes antérieures. Au milieu de ces organes, on trouve la voie, la ventrale, inférieure, et latéralement, on devine ici les reins, et les yeux de terre. D'accord ? Donc les rapports postérieurs, ou les rapports qui se trouvent en arrière, c'est la paroi abdominale antérieure, et les organes rétro-péritoriaux qui sont présentés au milieu par les gros vaisseaux, qui sont l'aorte et la ventrale antérieure, et latéralement, il y a les reins et les yeux de terre.

Je pense que le schéma illustre ces rapports-là. Donc en haut, vous voyez ici l'origine. En haut, les rapports supérieurs sont présentés par le côlon transverse et son maison.

C'est-à-dire le maison-côlon transverse. En bas, on trouve le côlon péri-fien, l'iliopéri-fien, le sigmoïd, le rectum, et les organes géopérien-binaires du tibocin. Ici, ce schéma, on conserve la femme.

Chez l'homme, on ne trouve pas d'étherus, mais on trouve les yeux de terre et les vaisseaux spermatiques. C'est pour cela que j'ai mentionné ici les organes géopérien-binaires du tibocin. Chez la femme, on trouve, en plus de l'œil de terre et des vaisseaux génétaux, on trouve l'étherus.

À gauche, il y a le côlon descendant et la paroi dominante latérale. À droite, il y a le côlon ascendant, le second, et la paroi dominante latérale. Jusqu'à ce niveau-là.

Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, est-ce qu'il est en contact avec l'abissi? En principe, l'abissi, il se trouve en sous-télétonial. Il est couvert par le télétran. D'accord? Donc l'étherus.

L'abissi se situe en avant de l'étherus et c'est l'étherus qu'on se trouve en contact avec l'intestin grec. Concernant la vascularisation et l'énervation de ce gynorhélium, donc la vascularisation artérielle de ce gynorhélium, elle provient de l'artère mesopérique supérieure qui est une branche de la rote. Donc cette artère mesopérique, elle va donner des artères intestinales qui sont en ordre de 12 à 15 et qui vont cheminer, comme on avait déjà dit, le mesenterre, c'est des portes-lances vaisseaux.

Donc ces artères intestinales, elles vont cheminer dans le mesenterre. Elles vont se diviser, vous voyez ces artères-là, elles vont se diviser en deux branches et ces branches-là, elles vont s'unir avec les branches des autres artères qui sont à côté et vont former ce qu'on appelle des artères artérielles du premier ordre. Et ainsi de suite.

Donc on aura chaque artère qui va se diviser en deux branches qui va s'unir avec les branches des artères qui sont à côté et vont former ce qu'on appelle des artères artérielles du premier ordre, deuxième ordre, et on peut avoir des artères artérielles du cinquième ordre. Pardon? Le deuxième ordre par rapport on a l'artère des endroits supérieurs qui va donner les artères intestinales, les premières artères sont artères juginales, les dernières sont les artères ligates. Ces artères, elles vont se diviser en deux branches.

Cette artère-là va se diviser en deux branches, celle-là en deux branches et les branches des deux artères, elles vont s'unir, elles vont former ce qu'on appelle les artères artérielles du premier ordre. Donc en avançant vers l'intestin il y aura, à un moment donné, deux autres branches qui vont s'anastomoser entre elles, elles vont donner des artères du deuxième ordre, et ainsi de suite. Vous voyez ici, c'est l'artère du premier ordre, c'est l'artère du deuxième ordre, et là, il y en a qu'une, deux artères du deuxième ordre, et après, la dernière artère elle va donner ce qu'on appelle les artères droites qui vont anastomoser les deux faces antérieures et postérieures de l'intestin grêle.

Sur l'enchaînement suivant, généralement, moyennement, trois à cinq artères seront conciliées avant que les vaisseaux grenent l'intestin, et la dernière série, c'est-à-dire la dernière série des artères, elle va donner les vaisseaux droits. Ça, c'est les vaisseaux droits. D'accord? Donc, ils sont pratiquement perpendiculaires au bord adhérent de l'once.

D'accord? Ces artères des vaisseaux droits, elles vont se diviser en deux branches. Donc, une branche antérieure qui va vasculariser la face antérieure de l'once, et une branche postérieure qui va vasculariser la face postérieure de l'once. Donc, chaque vaisseau droits, il va se diviser, comme on l'a vu, en deux branches antérieures et postérieures, et qui vont être destinées à la face des sphixies.

C'est-à-dire que les anticyclones syndicales, elles forment une antarsérie dans l'astromose. À l'intérieur de la part de l'anticyclone, il y a des astromoses, et on a déjà vu le schéma d'Eston. Donc, ce vaisseau-là, comme ça, c'est la fumiteuse qui est très bien vascularisée.

Vous voyez ici, c'est un vaisseau qui est droit, et qui va se diviser en deux branches. Donc, une va vasculariser la face postérieure, l'autre, la face postérieure. Donc, ce vaisseau, il se met surtout au niveau de la fumiteuse, qui est la pousse la plus vascularisée de l'intestin.

Le retour veineux est assuré par les veines jugulaires et gliales, et elle va se faire vers la veine mesopérique supérieure. Le retour veineux est fait par les veines jugulaires et gliales, vers la veine mesopérique supérieure. On va voir dans le cours de l'art, cette veine mesopérique supérieure, elle va former, avec ce qu'on appelle le temps scléromyséraiïque, le tampon.

Donc, tout le sang veineux du tube ici, va cheminer vers le foie avant qu'il gagne le cœur. Et le foie s'il le filtre, veineux, le sang de retour du tube digestif. D'accord ? Et l'emphatique, donc la lame, elle est connectée soit directement dans ce qu'on appelle le temps intestinal, sinon par des groupes l'emphatique, des groupes mesopériques, préavortiques et latéraux avortiques.

Donc, il y a certains partis, c'est difficile à les expliquer, mais il faut les apprendre par cœur. Donc, donc, dans la révision, il vaut mieux voir les anciens exemples pour s'orienter au niveau du cours. Pour les parties qui sont très intéressantes, pour les fixés, et pour vous.

Encore une fois, s'il vous plaît. Donc, c'est l'emphatique, le nom de leur trajet, il se décrit le

nombre d'embryons, l'emphatique mesopérique, donc le nombre d'insertions de mesentères, et même au niveau du mesopérique, s'il vous plaît. Donc, on va distinguer nos groupes, les groupes territoriaux, et au contact des bords mesopériques de l'Anse, un groupe intermédiaire, et un groupe qui dit central.

Ensemble, ils vont se diriger vers le canal l'envers gauche, puis vers la citade de Piquet. L'innovation du génie, non, elle provient du luxe mesopérique supérieur.